

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Anaphylaxie / Réaction allergique sévère

Urgence vitale : adrénaline intramusculaire immédiate, appel au 15 et surveillance continue.

Indications

- Atteinte respiratoire ou circulatoire brutale après exposition possible à un allergène.
- Urticatoire/cedème avec dyspnée, stridor, sifflements, malaise ou hypotension.
- Atteinte de deux systèmes après médicament, aliment, piqûre, vaccin ou latex.
- Une atteinte cutanée peut être absente.

Vérifications préalables

- Évaluer voies aériennes, respiration, TA, pouls, conscience et SpO2.
- Arrêter l'exposition si possible ; appeler du renfort.
- Allonger avec jambes surélevées ; demi-assis seulement si la dyspnée l'impose.
- Préparer adrénaline 1 mg/mL ou auto-injecteur nominatif.

Recommandations / IMPORTANT

- Appeler le 15 et injecter sans attendre : aucune contre-indication absolue en anaphylaxie.
- Ne jamais faire lever ou marcher le patient ; PLS si inconscient et respiration normale.
- Antihistaminique et corticoïde ne remplacent pas l'adrénaline.
- La voie IV d'adrénaline est réservée à une équipe médicale entraînée.

Intervention IDE

- Adrénaline IM face antérolatérale de cuisse : adulte/ado 0,5 mg = 0,5 mL de solution 1 mg/mL.
- Enfant : 0,01 mg/kg IM, sans dépasser 0,5 mg par injection.
- Auto-injecteur nominatif 150/300/500 microgrammes : utiliser la dose du plan individuel et du RCP de la marque.
- Si symptômes persistants, répéter l'adrénaline IM après 5 min ; oxygène haut débit si détresse.

Surveillance et traçabilité

- Surveillance continue : TA, FC, FR, SpO2, conscience et évolution cutanée.
- Tracer allergène suspect, début des signes, dose, voie, site et heure de chaque injection.
- Préparer transfert, transmission et emballage du produit suspect.
- Ne jamais laisser seul, même après amélioration.

Alerte immédiate

- Appel 15 obligatoire pour toute anaphylaxie.
- Rappeler sans délai si aggravation, deuxième dose nécessaire, détresse respiratoire, collapsus ou inconscience.
- En arrêt cardiaque : réanimation selon protocole et défibrillateur.

Mention de sécurité

L'adrénaline IM précoce est le traitement de référence. Vérifier la concentration 1 mg/mL et la dose avant injection ; poursuivre l'évaluation clinique et suivre les consignes du SAMU. Compte rendu IDE écrit, daté et signé au dossier.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :